LAB UC14 · COMPRIMIDO

Tabata · T11: 9 obj A–D + 1 disc, 10% cada · "paciente 1 e 2, respectivamente" · **sem referência** · roxo = caiu na T11

MÉTODO

- N / ↑ / ↓ em **todo** número → sobra o padrão
- Resolve o paciente fácil → corta metade (alternativas em par)
- Errada típica = acerta 1 paciente, erra o outro
- Disc: incompleto ou múltiplo = 0 → **1 diagnóstico + 1 fase**

NÚMEROS DE CABEÇA

TTOL	subir **≥ 20** mg/dL = absorve
pH fecal	< 5,6 → fermentação (lactose)
Calprotectina	< 50 SII · 50–150 repetir · > 150 orgânica
Elastase fecal	> 200 normal · < 200 insuf. pancreática
Amilase/lipase	> 3× LSN = aguda (amil 30–118 · lip 13–60)
GASA	≥ 1,1 portal · < 1,1 exsudato
Proteína ascite	2,5 (algoritmo) · 3,0 (tabela)
Ascite células	PMN > 250 peritonite · leuco > 500 exsudato
AST/ALT	≈ 1 normal · > 2 álcool · < 1 viral
Leucograma	neut 1.500–7.000 · linf 1.000–4.500 · eos ≤ 500 · bast ≤ 8%
Hepatite crônica	> 6 meses

SP1 · DIARREIA

Celíaca: autoimune; gliadina desaminada pela tTG → imunogênica → atrofia vilositária. **Anti-tTG IgA** = mais eficiente/prático · EmA caro · anti-DPG · biópsia confirma. Caso: diarreia crônica, ↓peso, anemia (até macro), **D-xilose ↓**, ácidos graxos +. Q1: tTG 45 = celíaca · Q8: tTG 2 = não é

Lactose: 50 g (2 g/kg criança), glicemia 0-30-60-120. ↑ < 20 = intolerante · pH < 5,6 · subst. redutoras. 2ª (celíaca, DII) → ache a base. Q1 +8 int · Q8 +17 int · **Q3 +39 NORMAL (pegadinha)**

DII: RCU = cólon/reto, sangue · Crohn = qualquer segmento, **delgado → ácidos graxos**. Calprotectina/lactoferrina = neutrófilo nas fezes. **ASCA+/pANCA− Crohn · ASCA−/pANCA+ RCU** (97% esp, ~50% sens). Q3: calpro 420 + AG+ = Crohn · calpro 22 = SII

Agentes: vírus → antígeno fezes (látex rota/adeno, PCR) · bactéria → coprocultura · parasita → parasitológico · fungo → pesquisa · toxina → presuntivo.

SP4 · SANGUE OCULTO / COPRO

Colorimétrico: peroxidase → Hb humana **e animal**, alimentos (beterraba, brócolis...), vit C interfere → **dieta 72 h**. **Imunoquímico**: anti-Hb humana, **sem dieta**. Itajaí: 45 × 13 (+) = 32 falso-positivos. Rastreio CCR.

Sangramento crônico → ferropriva: VCM ↓, HCM ↓, RDW ↑. Q7 P2: VCM 72, HCM 23, SO+

Gordura neutra	lipase ↓ ou bile ↓
Ácidos graxos	causa intestinal (não absorveu)
Amido	amilase ↓
Fibras musculares	tripsina ↓
pH ácido · alcalino	má abs. carboidrato · pouca fibra/ATB

Copro **fibras + gordura neutra + amido ++** = pâncreas (Q8, Q9). Dieta de prova 72 h (carne, batata, feijão, leite, manteiga).

H. pylori: antígeno → fezes · IgG → sangue (barato, sensível; não prova cura).

SP2 · PÂNCREAS E FÍGADO

PA aguda = 2 de 3: dor em faixa→dorso · enzima > 3× imagem. Amilase ↑ 5–8 h, pico 12–72 h, **20% normal**. Lipase ↑ 4–8 h, pico 24 h. **Crônica**: fibrose → enzimas normais/↓, elastase < 200, copro ++.

Q8 × Q9: mesmo etilista, elastase ↓, copro ++. Amil 13/lip 6 = crônica · amil 448/lip 213 = aguda.

Lesão	AST/ALT ↑↑ · bili ambas
Colestase	FAL/GGT ↑↑ · BD ↑ · AST/ALT pouco
Disfunção	albumina ↓ · TAP ↑ · ureia ↓ · BI ↑

Q9 P2: FAL 1240, GGT 420, BD 7,2, TAP normal = colestase (não disfunção)

Bilirrubina: heme → BI (+albumina, não filtra) → fígado conjuga → BD → bile → urobilinogênio → estercobilina (fezes) / urobilina (urina). **Hemólise**: BI ↑, urobilinogênio ↑, bili urina −. **Colestase**: colúria, acolia, urobilinogênio ↓.

SP2 · ASCITE

	Transudato	Exsudato
Aspecto	límpido	turvo
Proteína	< 3	> 3
Albumina	< 50% sérico	> 50%
LDH	< 200	> 200
Razão prot · LDH	< 0,5 · < 0,6	> 0,5 · > 0,6
GASA	> 1,1	< 1,1

GASA ≥ 1,1: prot < 2,5 **cirrose** · > 2,5 **cardíaca**. GASA < 1,1 + prot > 2,5: **ADA/BAAR** TB · **citologia** carcinomatose · **amilase > 100** pancreática. Nefrótica: prot < 2,5. PBS: LDH > 225, glicose < 50, prot > 1. Bilirrubina alta = perfuração biliar.

Q2: GASA 2,8 = portal · GASA 0,5 + 3.200 leuco PMN = exsudato infec/neo (ADA normal tira TB). **Q4: GASA 1,5 mas urina espumosa, prot +++, alb 2,1 = NEFRÓTICA** (clínica > GASA).

SP2 · URINA ESCURA E ANEMIAS

Fita "sangue" detecta **Hb (íntegra ou livre) + mioglobina**; porfirina não.

Fita + · muitas hemácias	sangramento: sem prot/cilindro + lombar→virilha = **litíase** · prot + dismórficas + cil. hemáticos = **glomérulo**
Fita + · hemácias raras	pigmento: Hb livre (**hemólise intravascular**, Hb ↓ BI ↑) · mioglobina (**rabdo**, CK ↑)
Fita – · urina vinho	**porfiria** (hemácias, Hb, BT normais)
Bilirrubina +	colestase
Cil. granulosos	tubular

Q5 litíase (105 mil hemácias) · **Q6 porfiria (fita –)** · Q7 P1 falciforme: VCM 88 + policromatofilia + BI ↑ + urobilinogênio, criança com dor recorrente.

Hemograma: bacteriana = neutrofilia + desvio (bastões ↑), granulações tóxicas, Döhle · viral = linfocitose, atípicos · parasita = eosinofilia (41%) + anemia (37%).

"OUTROS" + "PENSE RÁPIDO"

Porfiria → porfirinas, ALA, urina · Falciforme → eletroforese Hb · Chumbo → ALA, ZPP · Ectópica → β-hCG seriado · Pielo/cistite → PU + urocultura · Litíase → PU · CAD → gasometria, ânion gap · Celíaca → anti-gliadina, anti-tTG · DII → calpro, ASCA, pANCA.

Fita + c/ micro normal → rabdo/hemólise · elastase ↓ → pancreatite · > 250 céls ascite → exsudato · urina vinho → porfiria · acolia + colúria → colestase · acidose metabólica → DM1.

SP3 · HEPATITES

A, E fecal-oral, não cronificam · **B, C, D** cronificam (> 6 m) · **D** só com HBsAg.

HAV: IgM 1 sem → 4–6 m = agudo · IgG vida toda = passado/vacina. **HCV**: RNA 1–3 sem (1º) · anti-HCV 30–120 d · ALT 1–3 m, flutua · anti-HCV **não** é cura. ~70% das crônicas.

HBsAg	tem vírus (1º, 30–40 d)
HBeAg	replica · crônico = mau prognóstico
Anti-HBc IgM	agudo (≤ 6 m)
Anti-HBc IgG	contato (passado/presente)
Anti-HBe	soroconversão = bom
Anti-HBs	imune: + anti-HBc = cura · sozinho = vacina

Aguda: HBsAg + IgM · Crônica: HBsAg > 6 m + IgG · Curada: IgG + anti-HBs · Vacinado: só anti-HBs · Resolução: sintomas some, ALT normaliza, HBsAg –, anti-HBs +.

Disc T11 = Hepatite C, crônica: anti-HAV IgG (passado) · B curada (IgG + anti-HBe + anti-HBs) · anti-HDV sem HBsAg (cicatriz) · anti-HCV + ALT 224 + 9 meses.